

UNIwersytet Medyczny _____

Wydział Nauk o Zdrowiu — Kierunek: Pielęgniarstwo

Anna Nowak

nr albumu 000000

Akceptacja choroby a jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 2

Praca magisterska

napisana pod kierunkiem

dr hab. n. o zdr. _____

[Miasto], 2026

Jak korzystać z tego wzoru. To kompletny szkielet empirycznej (badawczej) pracy magisterskiej z pielęgniarstwa z przykładową treścią i komentarzami. Niebieskie adnotacje opisują funkcję każdej części — usuń je w swojej pracy. Treść, dane liczbowe i nazwiska są ilustracją. Pamiętaj, że badania z udziałem pacjentów wymagają zwykle zgody komisji bioetycznej i zgody placówki — to specyfika pielęgniarstwa. Sprawdź wytyczne uczelni. Pełne poradniki: praca-magisterska.pl/poradniki/

Streszczenie

Wstęp: Cukrzyca typu 2 jest chorobą przewlekłą, której przebieg w dużej mierze zależy od codziennych zachowań pacjenta. Stopień akceptacji choroby może wpływać na jakość życia i skuteczność samoopieki. Cel: Ocena związku między poziomem akceptacji choroby a jakością życia pacjentów z cukrzycą typu 2. Materiał i metody: Badaniem objęto 120 pacjentów poradni diabetologicznej. Zastosowano Skalę Akceptacji Choroby (AIS) oraz kwestionariusz jakości życia WHOQOL-BREF. Wyniki: Wykazano dodatni związek między akceptacją choroby a jakością życia we wszystkich domenach ($p < 0,001$). Wnioski: Wzmacnianie akceptacji choroby, m.in. przez edukację prowadzoną przez pielęgniarkę, może poprawiać jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 2.

Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, akceptacja choroby, jakość życia, opieka pielęgniarska.

[W pracach medycznych streszczenie bywa wymagane w układzie strukturalnym (Wstęp – Cel – Materiał i metody – Wyniki – Wnioski). Sprawdź, czy Twoja uczelnia wymaga takiego podziału, oraz dołącz wersję angielską (Abstract).]

Spis treści

Wstęp	3
Rozdział 1. Cukrzyca typu 2 i akceptacja choroby w świetle literatury	5
1.1. Epidemiologia, obraz kliniczny i powikłania cukrzycy typu 2	5
1.2. Akceptacja choroby przewlekłej — ujęcie teoretyczne	9
1.3. Jakość życia w chorobie przewlekłej	12
1.4. Rola pielęgniarki w opiece i edukacji diabetologicznej	15
Rozdział 2. Założenia metodologiczne badań własnych	18
2.1. Cel, problemy badawcze i hipotezy	18
2.2. Metoda, techniki i narzędzia badawcze	20
2.3. Organizacja i przebieg badań	23
2.4. Charakterystyka grupy badanej	24
Rozdział 3. Analiza wyników badań własnych	27
3.1. Poziom akceptacji choroby i jakości życia	27
3.2. Weryfikacja hipotez	31
Rozdział 4. Dyskusja	36
Wnioski	40
Piśmiennictwo · Spis tabel · Aneks	42

Wstęp

[Akapit 1 — kontekst i skala problemu, najlepiej z danymi epidemiologicznymi.]

Cukrzyca typu 2 należy do najczęstszych chorób przewlekłych w Polsce — choruje na nią ponad dwa miliony dorosłych, a liczba ta systematycznie rośnie. Skuteczność leczenia zależy w dużej mierze nie od samej farmakoterapii, lecz od codziennych decyzji pacjenta dotyczących diety, aktywności fizycznej i samokontroli glikemii.

[Akapit 2 — luka i uzasadnienie: dlaczego akceptacja choroby i jakość życia, dlaczego w opiece pielęgniarskiej.]

W podejściu opartym na dowodach (Evidence-Based Practice) coraz większą wagę przypisuje się psychosocjalnym uwarunkowaniom przebiegu choroby. Jednym z nich jest akceptacja choroby — stopień, w jakim pacjent godzi się z ograniczeniami wynikającymi ze schorzenia. Związek akceptacji choroby z jakością życia pacjentów z cukrzycą typu 2 w polskich warunkach nie został dotąd dostatecznie opisany, co uzasadnia podjęcie tematu.

[Akapit 3 — cel pracy i zapowiedź struktury.]

Celem pracy jest ocena związku między poziomem akceptacji choroby a jakością życia pacjentów z cukrzycą typu 2. Praca składa się z części teoretycznej, rozdziału metodologicznego oraz analizy wyników badań własnych zakończonej dyskusją i wnioskami.

Rozdział 2. Założenia metodologiczne badań własnych

2.1. Cel, problemy badawcze i hipotezy

Cel pracy. Ocena związku między poziomem akceptacji choroby a jakością życia pacjentów z cukrzycą typu 2.

Problemy badawcze:

1. Jaki jest poziom akceptacji choroby w badanej grupie?
2. Jaki jest poziom jakości życia badanych w poszczególnych domenach?
3. Czy istnieje związek między akceptacją choroby a jakością życia?

Hipotezy:

- **H1:** Wyższy poziom akceptacji choroby wiąże się z wyższą jakością życia we wszystkich domenach.
- **H2:** Zmienne socjodemograficzne (wiek, czas trwania choroby) różnicują poziom akceptacji choroby.

2.2. Metoda, techniki i narzędzia badawcze

W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Wykorzystano dwa wystandaryzowane narzędzia: **Skalę Akceptacji Choroby (AIS)** oraz kwestionariusz **WHOQOL-BREF** do oceny jakości życia, a także autorską metryczkę. Rzetelność skal w badanej próbie oceniono współczynnikiem alfa Cronbacha.

[To charakterystyczne dla pielęgniarstwa: korzystaj z uznanych, wystandaryzowanych skal właściwych dla problemu (np. AIS, WHOQOL-BREF, Barthel, Norton, NRS/VAS, MNA). Każdą skalę opisz i podaj jej rzetelność. Narzędzia autorskie rezerwuj dla metryczki i pytań o fakty.]

2.3. Organizacja i przebieg badań

Badanie przeprowadzono wśród pacjentów poradni diabetologicznej po uzyskaniu **zgody komisji bioetycznej** oraz zgody kierownictwa placówki. Udział był dobrowolny i anonimowy; każdy pacjent wyraził świadomą zgodę po zapoznaniu się z celem badania.

[Zgoda komisji bioetycznej i zgoda placówki to standard w badaniach pielęgniarstwie z udziałem pacjentów — opisz je w procedurze. Bez tego recenzent zakwestionuje stronę etyczną pracy.]

2.4. Charakterystyka grupy badanej

W badaniu wzięło udział 120 pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 2 (58% kobiet, 42% mężczyzn). Średni wiek wyniósł 62,3 roku, a średni czas trwania choroby — 9,1 roku.

Rozdział 3. Analiza wyników badań własnych

3.2. Weryfikacja hipotez

Stwierdzono dodatni, istotny statystycznie związek między akceptacją choroby (AIS) a jakością życia (WHOQOL-BREF) we wszystkich domenach. Współczynniki korelacji przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Korelacje akceptacji choroby (AIS) z domenami jakości życia (r-Pearsona; N = 120)

Domena jakości życia (WHOQOL-BREF)	r	p
Fizyczna	0,51	< 0,001
Psychologiczna	0,47	< 0,001
Relacje społeczne	0,38	< 0,001
Środowiskowa	0,34	< 0,001

Źródło: badania własne.

[Tabele numeruj i tytułuj (tytuł nad tabelą), podawaj źródło. W tekście opisz tendencję, nie powtarzaj wszystkich liczb. Interpretacja należy do dyskusji.]

Rozdział 4. Dyskusja

Uzyskane wyniki są spójne z dotychczasowymi badaniami wskazującymi na ochronną rolę akceptacji choroby dla dobrostanu pacjentów przewlekle chorych. Najsilniejszy związek z domeną fizyczną można tłumaczyć tym, że pacjenci akceptujący chorobę chętniej podejmują samoopiekę.

[Dyskusja konfrontuje wyniki własne z piśmiennictwem z rozdziału teoretycznego. Wskaż zbieżności i rozbieżności oraz ich możliwe przyczyny; nie wprowadzaj nowych danych.]

Wnioski

1. Pacjenci z cukrzycą typu 2 prezentowali zróżnicowany poziom akceptacji choroby.
2. Wyższa akceptacja choroby wiązała się z wyższą jakością życia we wszystkich domenach.
3. Wskazane jest uwzględnienie wsparcia akceptacji choroby — m.in. przez edukację pielęgniarską — w opiece nad pacjentem z cukrzycą typu 2.

Piśmiennictwo

[W pracach pielęgniarskich i medycznych dominuje styl Vancouver: źródła numeruje się w kolejności cytowania w tekście. Sprawdź wytyczne uczelni — część dopuszcza APA.]

1. Araszkiewicz A i wsp. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u osób z cukrzycą 2025. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Curr Top Diabetes. 2025.
2. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Wyd. 2. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP; 2012.
3. Szewczyk A, red. Pielęgniarstwo diabetologiczne. Warszawa: PZWL; 2019.

Aneks

[W aneksie umieszcza się narzędzia i dokumenty: kwestionariusz, zgodę komisji bioetycznej, wzór świadomej zgody pacjenta. Poniżej fragment metryczki.]

Metryczka (fragment): 1. Płeć: kobieta / mężczyzna. 2. Wiek: 3. Czas trwania cukrzycy (w latach): 4. Leczenie: dieta / leki doustne / insulina. 5. Powikłania cukrzycy: tak / nie.